



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE, HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

DIRECTION DE CONTRÔLE DES MALADIES

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA R.D.C

Présentée lors de la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies (CNC)

Semaine Épidémiologique 29 • Réunion du 29 juillet 2026



EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique en RDC, SE29-2026



3 200 CUMUL CONFIRMÉS



43,9% LÉTALITÉ GLOBALE



5 PROVINCES AFFECTÉES



48 ZS AFFECTÉES



22,0 TAUX POSITIVITÉ



82,1% OCCUPATION LITS



77,8% SUIVI CONTACTS



571 CUMUL GUÉRIS

Tendance des cas confirmés

Cas confirmés par semaine de début des symptômes

Données du 26 juillet 2026 · n = 2 431 cas renseignés · délai médian début → notification = 4 j

Semaine épidémiologique de début des symptômes	Décédé	Vivant / Inconnu
SE17 2026	2	0
SE18 2026	10	10
SE19 2026	15	15
SE20 2026	20	80
SE21 2026	40	100
SE22 2026	45	135
SE23 2026	75	145
SE24 2026	95	165
SE25 2026	85	185
SE26 2026	90	180
SE27 2026	115	220
SE28 2026	80	200
SE29 2026	70	180
SE30 2026	40	50

Source : liste linéaire DHIS2 (non réconciliée)

	Médiane par semaine	Médiane par jour
Cas confirmés vivant	147	32
Cas confirmés décès	72	18
Dans l'ensemble	241	50

Sources : INSP • COUSP • SGI • DHIS2

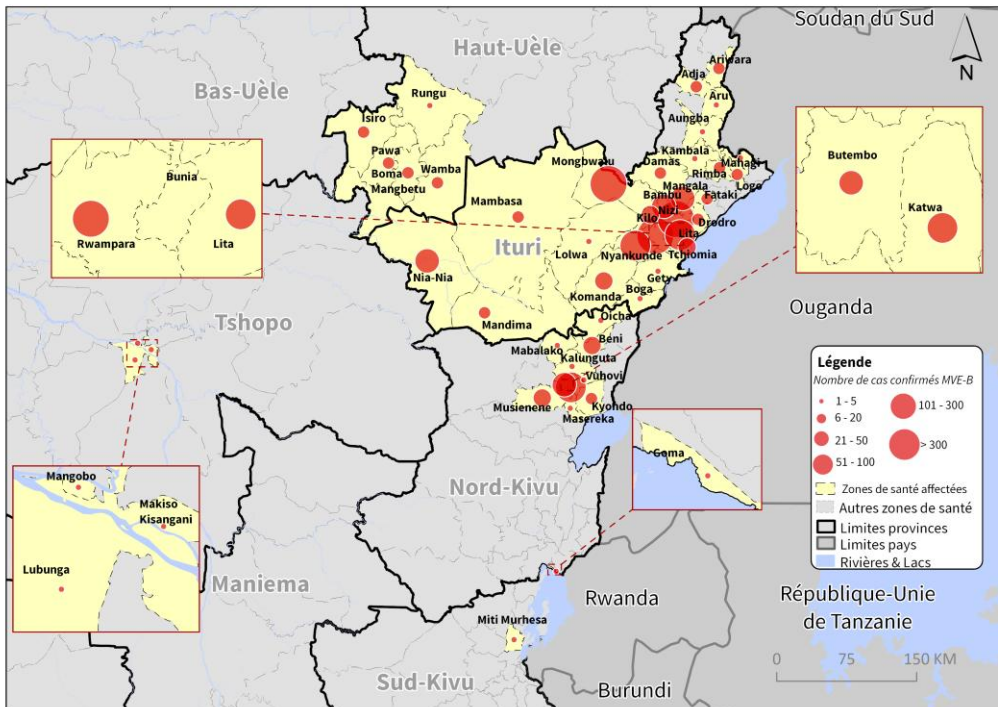
EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique

Distribution géographique des cas



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Carte de la distribution spatiale globale

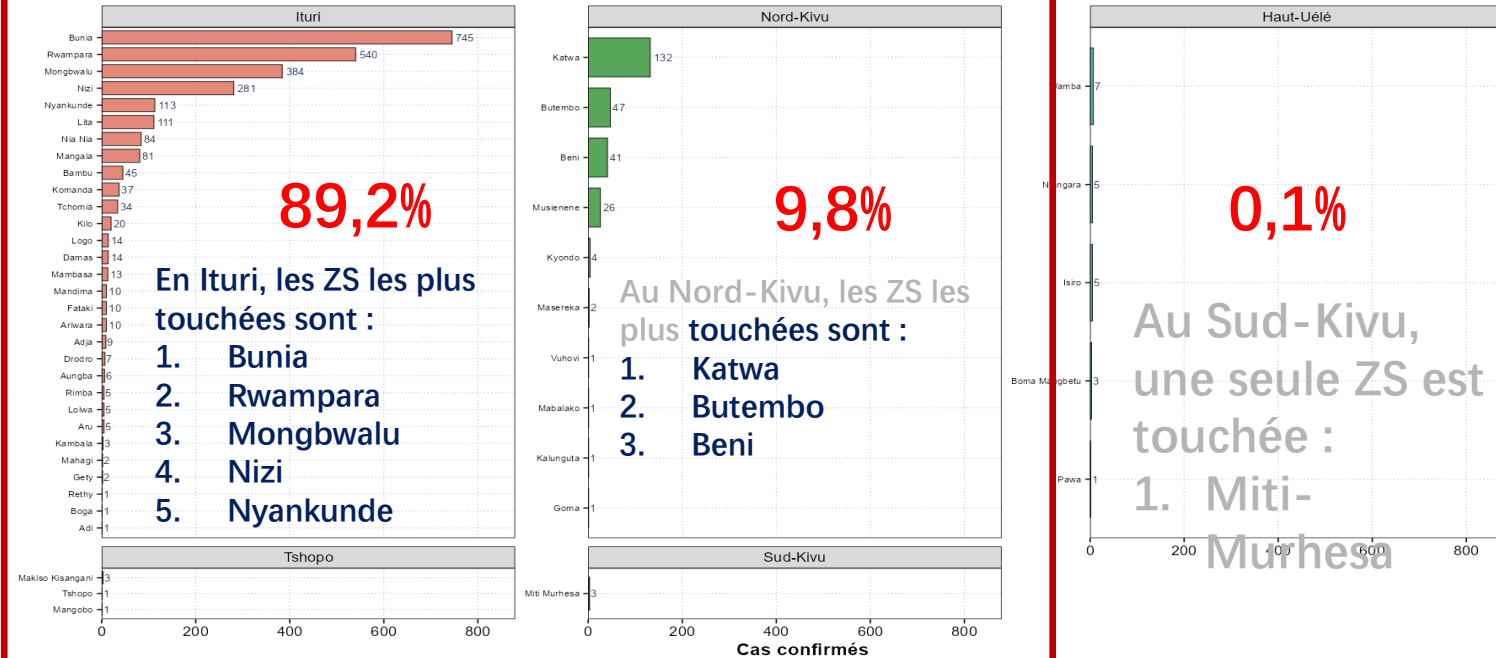


**48 ZS dans 5 provinces
(Haut-Uélé, Ituri, Nord-
Kivu, Sud-Kivu et Tshopo)**

Distribution par province et zones des santé

Cas confirmés par zone de santé et par province, N = 2 878

Données du 26 juillet 2026



En Ituri, les ZS les plus touchées sont :

1. Bunia
2. Rwampara
3. Mongbwalu
4. Nizi
5. Nyankunde

Au Nord-Kivu, les ZS les plus touchées sont :

1. Katwa
2. Butembo
3. Beni

Au Sud-Kivu, une seule ZS est touchée :

1. Miti-Murhesa

A la Tshopo, les ZS les plus touchées sont :

1. Makiso-Kisangani
2. Mangobo
3. Lubunga

Au Haut-Uele, quatre ZS touchées :

1. Wamba
2. Isiro
3. Pawa
4. Boma Mangbetu



EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique: Zones de santé les plus touchées



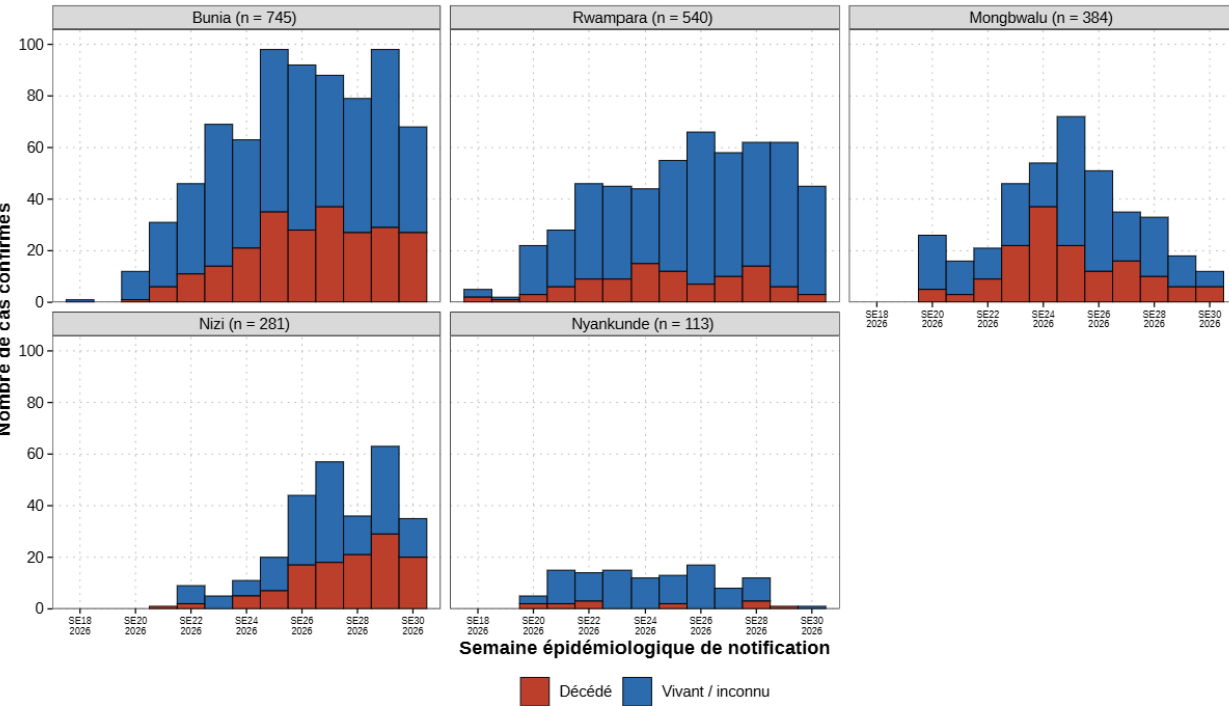
Zones de santé	Cumul cas confirmés	% du total des cas confirmés	Cumul des décès	Taux brut de létalité	% du total des décès
ITURI	2 733	88,9 %	1 142	41,8 %	84,3 %
Bunia	739	24,0 %	200	27,1 %	14,8 %
Rwampara	515	16,7 %	236	45,8 %	17,4 %
Mongbwalu	490	15,9 %	232	47,3 %	17,1 %
Nizi	330	10,7 %	158	47,9 %	11,7 %
Nyankunde	114	3,7 %	30	26,3 %	2,2 %
Autres zones	545	17,7 %	286	52,5 %	21,1 %
NORD-KIVU	299	9,7 %	188	62,9 %	13,9 %
Katwa	136	4,4 %	88	64,7 %	6,5 %
Butembo	66	2,1 %	43	65,2 %	3,2 %
Beni	42	1,4 %	29	69,0 %	2,1 %
Musienene	29	0,9 %	14	48,3 %	1,0 %
Kyondo	11	0,4 %	7	63,6 %	0,5 %
Autres zones	15	0,5 %	7	46,7 %	0,5 %
SUD-KIVU	3	0,1 %	1	33,3 %	0,1 %
Miti-Murhesa	3	0,1 %	1	33,3 %	0,1 %
HAUT-UÉLÉ	35	1,1 %	19	54,3 %	1,4 %
Isiro	11	0,4 %	7	63,6 %	0,5 %
Wamba	10	0,3 %	4	40,0 %	0,3 %
Pawa	7	0,2 %	5	71,4 %	0,4 %
Boma Mangbetu	6	0,2 %	3	50,0 %	0,2 %
Rungu	1	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TSHOPO	5	0,2 %	4	80,0 %	0,3 %
Makiso-Kisangani	3	0,1 %	3	100,0 %	0,2 %
Lubunga	1	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Mangobo	1	0,0 %	1	100,0 %	0,1 %
Total	3 075	100,0 %	1 354	44,0 %	100,0 %

Sitrep 71. Date de rapportage: 26 Juillet 206. Date de publication: 27 juillet 2026

Evolution hebdomadaire de cas confirmés (semaine de notification) dans les ZS de l'Ituri

Tendance hebdomadaire des cas confirmés de MVB par zone de santé en Ituri

Données du 26 juillet 2026 · n = 2 063 cas · décès = 614



Source : liste linéaire DHIS2 (non réconciliée)

Les 6 ZS les plus touchées sont tous localisées dans la DPS de l'Ituri et compte 78,6% de cas confirmés et 72,3% de décès parmi les confirmés rapportés dans l'ensemble du pays.



EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique:

Distribution Âge et Sexe

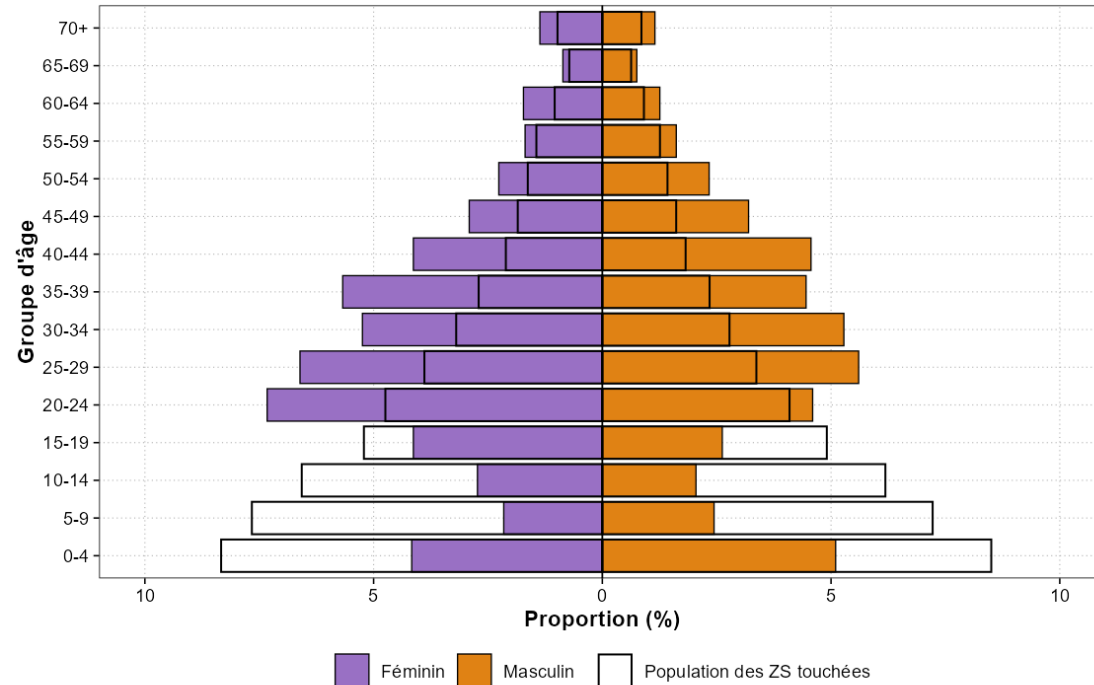


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Distribution des cas confirmés par sexe

Pyramide d'âge-sexe des cas confirmés de MVE-Bundibugyo

Données du 26 juillet 2026 · n = 2 784 cas renseignés · référence : 9 634 229 hab. (49 ZS touchées)

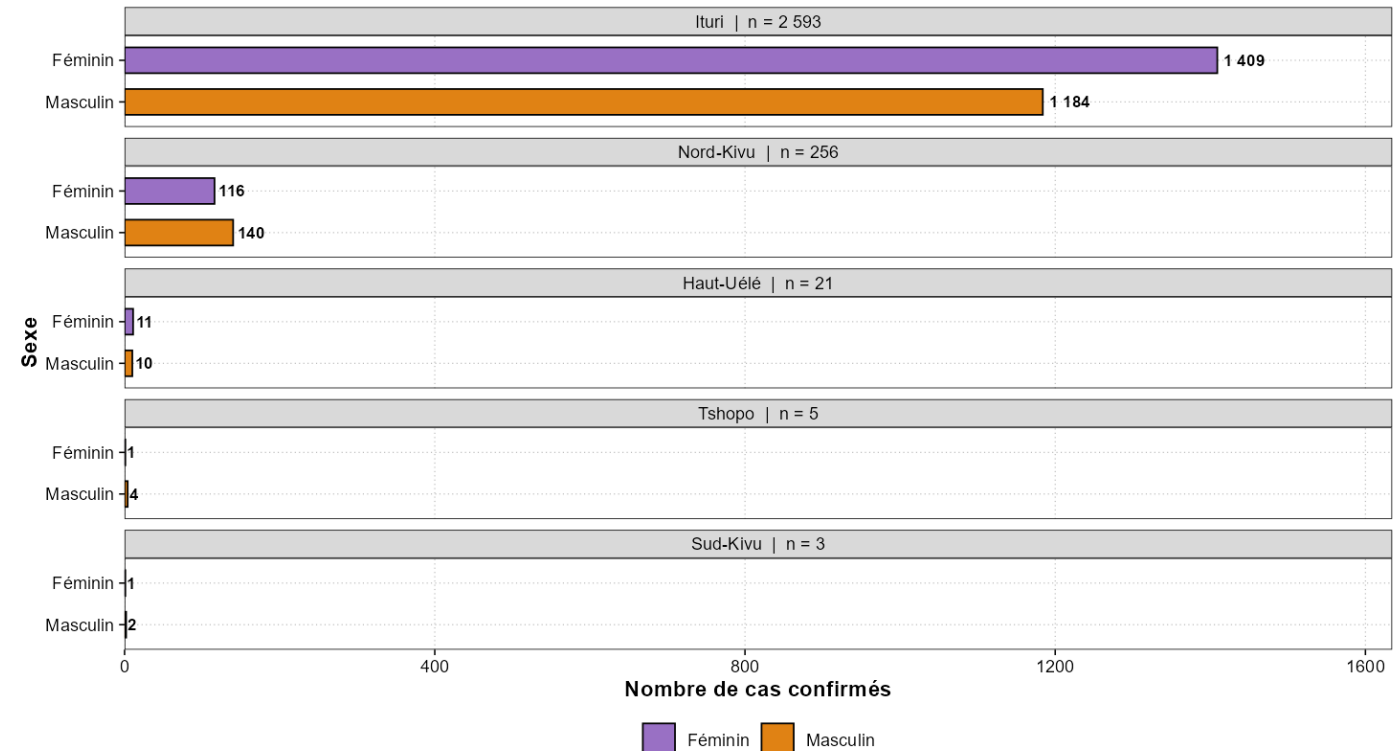


Source : liste linéaire DHIS2 (non réconciliée)

- Globalement, les femmes représentaient 54 % (892/1641) des cas confirmés
- Le groupe d'âge 20–40 ans était la démographie la plus touchée

Cas confirmés de maladie à virus Bundibugyo par sexe et par province, N = 2 878

Données du 26 juillet 2026



Source : liste linéaire DHIS2 (non réconciliée)

Au Nord-Kivu et Sud-Kivu, les hommes sont plus touchés que les femmes, contrairement en Ituri



MPOX: Evolution de la situation épidémiologique de la Mpox SE29-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Cas Suspects
(IDSR)

SE29: 615

Cumul en 2026:24889

Décès
(IDR)

SE29: 8(1,3%),

Cumul :282(1,1%)

Cas investigués
(LL)

SE29:192

Cumul: 6047 non à jour

Cas prélevés
(LL)

SE29: 192 Cumul:ND

Taux prélev:ND;100%

Cas avec échantillons reçus
et testés (BD Labo)

SE29 :192

Cumul:4067 non à jour

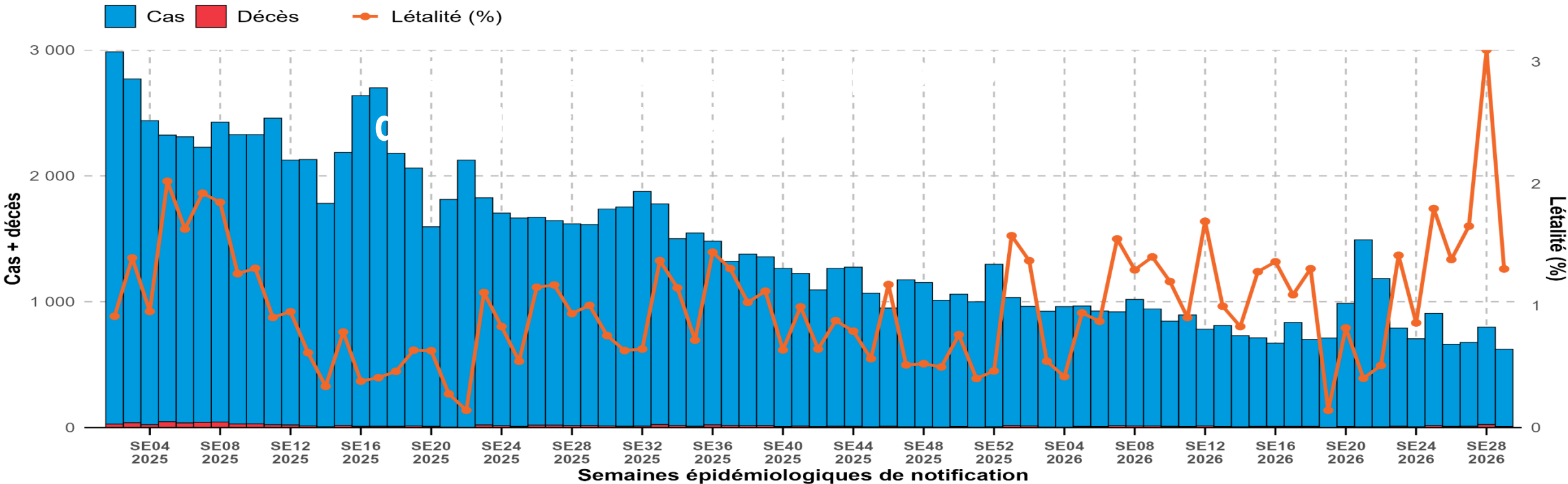
Cas confirmés
(BD labo)

SE29:55

Cumul :ND

Pos:28.6 %

Notification hebdomadaire des cas, décès et létalité – MPOX



Sources : INSP •COUSP •SGI • DHIS2

Cumul : 114 287 cas, 1 105 décès, létalité 1%
Moyenne hebdomadaire : 1 429 cas (ET = 608)
Pic : 2 958 cas (2025-SE02)
Variation : -20.6% (dernière semaine vs précédente)



MPOX: Evolution de la situation épidémiologique de la Mpox

SE29-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

SITUATION DU TESTING



Indicateurs S29



Echantillons prélevés : 192



Echantillons reçus : 192



Echantillons testés : 192



Echantillons positifs : 55



Taux d'analyse : 100 %



Taux de positivité : 28.6%

INDICATEUR DE PERFORMANCE PAR LABORATOIRE

Laboratoire	Recus	Analysés	Positif	% positif	Négatif	% Négatif	Indéterminé	% Indeterminé	Invalide	% Invalide
INRB KIN	81	81	02	2.5	79	97.5	0	0	0	0
TSHUAPA	41	41	32	78.0	03	7.3	4	9.8	2	4.9
Tanganyika	6	6	3	50	3	50	0	0	0	0
LUALABA	02	02	1	50	1	50	0	0	0	0
KINOISE	6	6	4	66.7	2	33.3	0	0	0	0
SANKURU	17	17	9	53.0	8	47.0	0	0	0	0
BUTA	6	6	3	50	1	50	2	0	0	0
NORD KIVU	33	33	1	3.0	31	93.9	0	0	1	3.0
Total	192	192	55	28.6	128	66.7	6	3.1	3	1.6

- 28.6% de cas positifs à la S29
- La majorité des laboratoires ont les résultats positifs qui dépassent 50%, Tshuapa et Kinoise ont plus de cas.
- sauf les 2 INRB qui ont 3% de positifs
- On remarque aussi des cas indéterminés à Tshuapa (9.8%) et Nord Kivu(3%)



MPOX: Evolution de la situation épidémiologique de la Mpox SE29-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

ANALYSE TAUX D'ATTAQUE A LA SEMAINE LES 3 DERNIERES SEMAINES

Provinces	Situation cumulée 2026			Situation SE27/2026			Situation SE28/2026			Situation SE29/2026			Taux de variation
	Cas	Décès	Létalité (%)	Cas	Décès	Létalité (%)	Cas	Décès	Létalité (%)	Cas	Décès	Létalité (%)	
Sankuru	9505	61	0,64	275	3	1,09	231	0	0,00	208	2	0,96	-9,96
Sud-Kivu	3959	2	0,05	81	0	0,00	63	0	0,00	74	0	0,00	17,46
Tshuapa	3448	140	4,06	172	6	3,49	307	19	6,19	186	5	2,69	-39,41
Tshopo	1282	33	2,57	24	2	8,33	33	1	3,03	21	1	4,76	-36,36
Nord Kivu	1250	0	0,00	11	0	0,00	33	0	0,00	14	0	0,00	-57,58
Equateur	969	6	0,62	15	0	0,00	16	0	0,00	23	0	0,00	43,75
Haut Uele	776	6	0,77	9	0	0,00	3	0	0,00	6	0	0,00	100,00
Sud-Ubangi	690	0	0,00	16	0	0,00	21	0	0,00	11	0	0,00	-47,62
Kasai	560	10	1,79	8	0	0,00	26	0	0,00	22	0	0,00	-15,38
Mongala	434	5	1,15	7	0	0,00	3	0	0,00	10	0	0,00	233,33
Tanganyika	281	1	0,36	8	0	0,00	6	1	16,67	8	0	0,00	33,33
Lomami	273	0	0,00	2	0	0,00	3	0	0,00	8	0	0,00	166,67
Bas Uele	241	1	0,41	6	0	0,00	4	0	0,00	0			-100,00
Kinshasa	179	0	0,00	4	0	0,00	1	0	0,00	7	0	0,00	600,00
Haut Katanga	174	3	1,72	2	0	0,00	1	0	0,00	2	0	0,00	100,00
Kwango	139	0	0,00				0			0			
Ituri	135	0	0,00				0			0			
Nord Ubangi	123	10	8,13	4	0	0,00	4	3	75,00	2	0	0,00	-50,00
Maindombe	118	1	0,85	1	0	0,00	5	0	0,00	1	0	0,00	-80,00
Maniema	115	1	0,87	4	0	0,00	1	0	0,00	4	0	0,00	300,00
Lualaba	99	1	1,01	4	0	0,00	10	0	0,00	6	0	0,00	-40,00
Kongo Central	50	0	0,00	1	0	0,00	0			0			
Kwilu	49	1	2,04	11	0	0,00	3	0	0,00	0			-100,00
Haut Lomami	20	0	0,00	1	0	0,00	1	0	0,00	2	0	0,00	100,00
Kasai Central	11	0	0,00				0			0			
Kasai Oriental	9	0	0,00	0	0		0	0		0			
Total	24889	282	1,13	666	11	1,65	775	24	3,1	615	8	1,3	-0,21

Sources : INSP • COUSP • SGI • DHIS2



Points saillants de la situation du choléra en RDC à la SE29_2026



ZS IREBU AS MALANGE

1. Plus de 50 cas suspects de choléra avec 3 décès à bord de HB Yangi Fangi en provenance de Yakata dans la province de la Tshopo pour Kinshasa ont été notifiés.
2. L'ECZ Irebu en préparatif d'une descente urgente pour évacuer des corps sans vie et mener les actions de santé publique.

Recommandations



1. Signaler les autorités portuaires pour une mise en quarantaine
2. Préparer les intrants pour une désinfection de l'embarcation
3. Rendre disponible la doxycycline pour une chimioprophylaxie
4. Préparer une navette pour le transfert des cas suspects vers le CTC
5. Mener les investigations approfondies



Choléra: Analyse hebdomadaire SE29-2026



Cas Notifiés

- 1331 cas suspect (VS 1010 cas en SE28)
- Hausse de + 24,12%)
- Nouvelle Zone de santé (Kasongo Lunda)



Décès SE 29

- **94 décès** (14 hospitaliers, 80 Communautaires)
- 13 décès/Jour
- létalité 1%



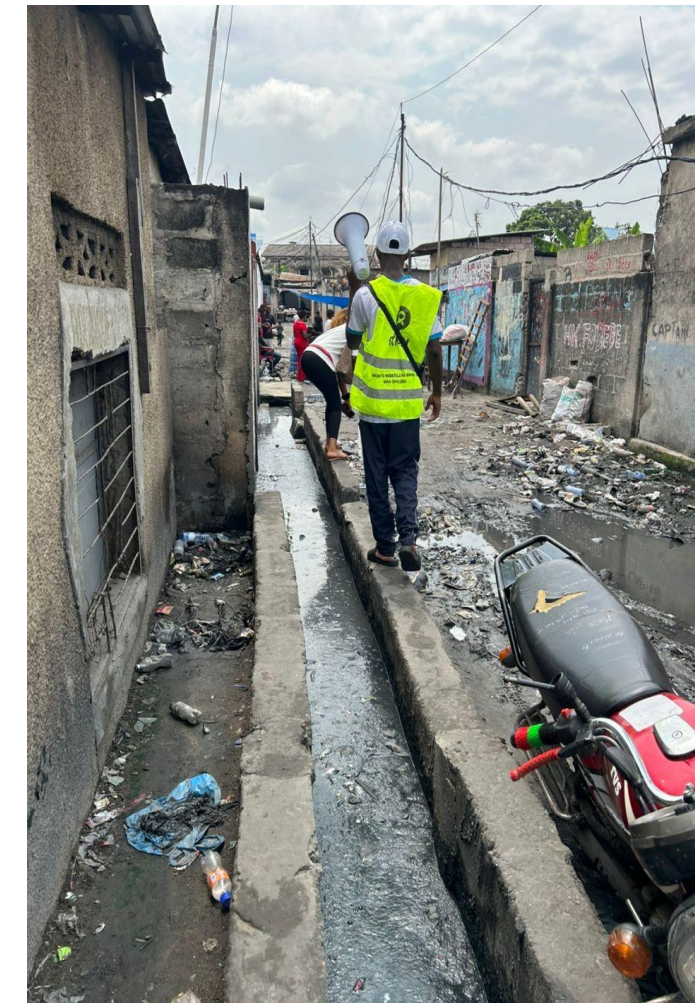
Cumul S1-S29 :

- 33025 cas suspects et **2602** confirmés, de (de 48,29% de positivité **165 cas suspects/Jour**)
- 841 décès (197 hospitaliers et 644 communautaire)



Couverture Annuelle

- **18** provinces touchées
- **194** ZS affectées
- Sud-Kivu: **25** % cas nationaux



Choléra: Analyse hebdomadaire SE29-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Incidence hebdomadaire de cas suspects de choléra et taux de létalité en RDC semaine
1-52, 2024, Semaine 29-2026

S29-2024

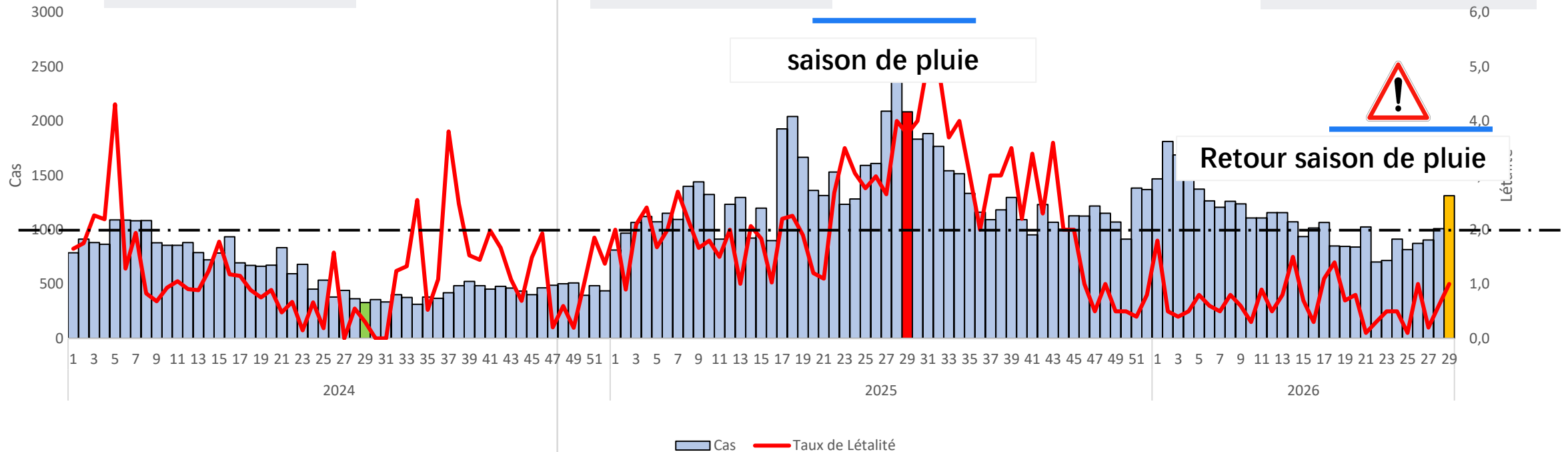
- 345 cas
- 11 décès
- 3,1 %T.L
- 7 provinces

S29-2025

- 2172 cas
- 18 décès
- 0,8 % T.L
- 15 provinces

S29-2026

- 1311 cas
- 14 décès Hosp
- 1 %T.L
- 11 provinces



➤ Hausse de cas notifiés après 8 semaines consécutives depuis 2025 de moins de 1000 cas par semaine



Choléra: Analyse hebdomadaire SE29-2026

Tendance de la situation épidémiologique du choléra S26-S29_2026

Provinces	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas SE29	Décès S29		LL	Ecart	T.L S29	TV S29-S28	ZS_Cas_S29
	S26	S26	S27	S27	S28	S28		Struct	Comm	S29	S28			
Sud-Kivu	229	3	307	13	330	13	495	4	18	232	263	0,8	33	15
Nord-kivu	273	2	274	0	241	1	293	0	0	168	125	0,0	18	7
Sud-Ubangi	44	19	73	7	112	13	270	6	50	ND	270	2,2	59	4
Kwango	109	6	43	4	56	1	113	0	8	113	0	0,0	50	3
Tanganyika	124	4	120	3	145	3	92	4	1	92	0	4,3	-58	3
Haut-Katanga	30	2	40	2	26	0	21	0	1	11	10	0,0	-24	3
Maindombe	7	1	28	0	28	2	20	0	0	20	0	0,0	-40	3
Sankuru	22	2	18	2	15	1	15	0	1	7	15	0,0	0	3
Kwilu	48	5	11	2	32	1	6	0	1	6	0	0,0	-433	1
Kongo Central	53	0	25	0	20	0	4	0	0	4	4	0,0	-400	3
Lualaba	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	2	0,0	100	1
Equateur	18	0	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinshasa	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	967	44	948	35	1010	35	1331	14	80	646	685	1,05	24,12	46

- Hausse de **+24,12%** entre S28 et S29.
- **Quatre DPS concentrent 87,9% des cas.**
- **3 provinces 2 endémiques & 1 épidémique :** > 200 cas/SE
- **1 province épidémiques :** > 100 cas notifiés
- **94 décès** en S29, dont 80 communautaires

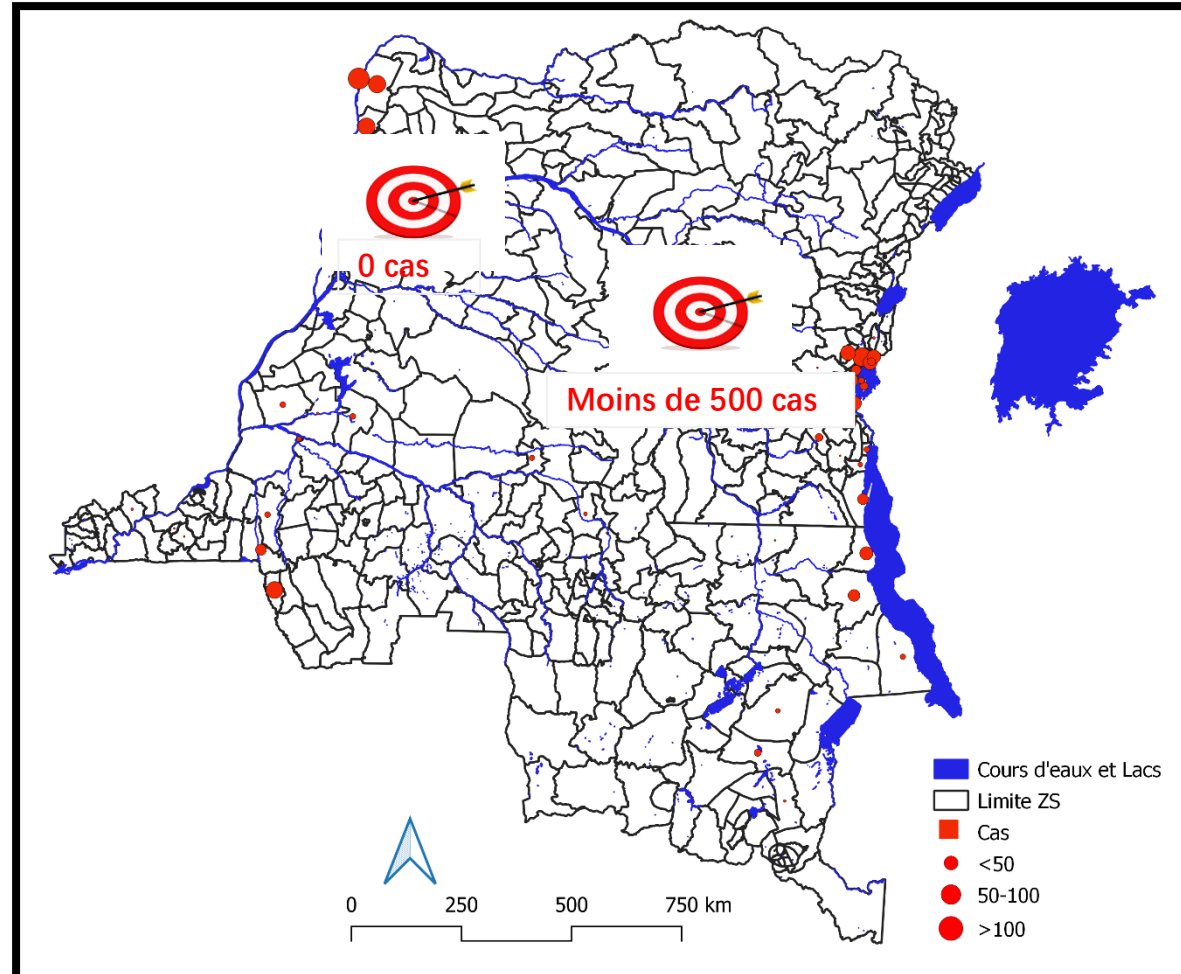


Répartition spatiale des cas suspects, en RDC S29, 2026

Provinces Epidémiques

DPS	Cas	Décès
Sud Ubangi	270	56
Kwango	113	8
Maindombe	20	0
Sankuru	15	1
Kwilu	6	1
Kongo C	4	0
Lualaba	2	0
Total	430	66

**36% cas aux Provinces
Epidémiques**



Provinces Endémiques

Sud-Kivu	Cas	Décès
Sud-Kivu	443	22
Nord-kivu	293	0
Tanganyika	91	5
Haut-Katanga	21	1
Total	848	28

**64% cas aux Provinces
endémiques**

La majorité des cas provient des **provinces endémiques** (848 cas), tandis que les **décès** se concentrent dans les provinces épidémiques (66 décès)



Choléra: Analyse hebdomadaire SE29-2026

Situation du choléra dans les provinces endémiques

SUD KIVU

***S29/2026 495cas/22 décès vs SE28
330 cas/13 décès (Hausse +33)***

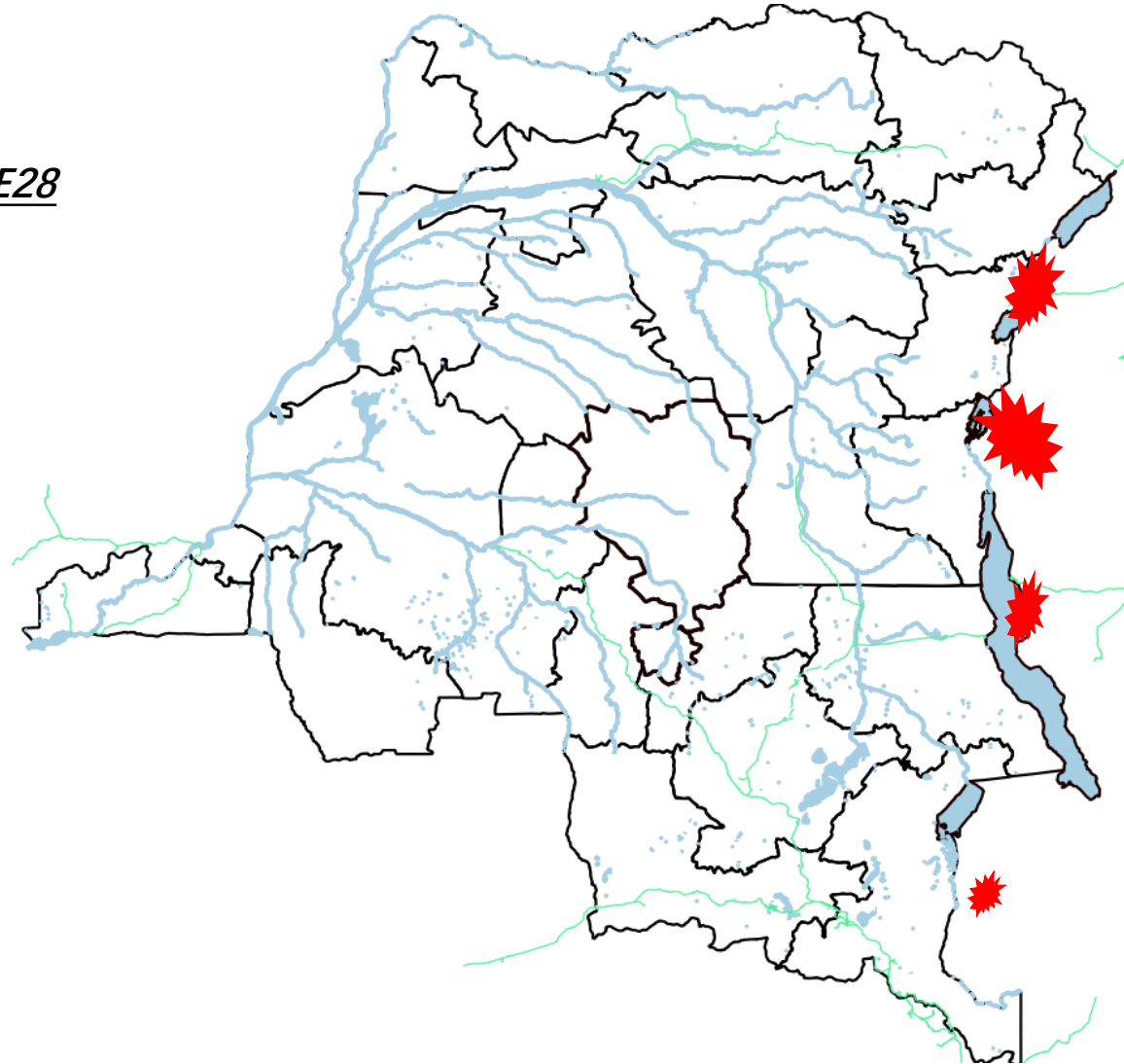
- Shabunda 148 cas/16 décès
- Mulungu 104 cas/2décès
- Ibanda 53 cas
- Kalehe 51 cas

Défis

- Manque d'intrants
- Personnels non formés
- Manque d'activité communautaire de lutte
- Distance entre ESS et épiceutre

Action en cours

- Déployer pour expédition des intrants par FICR
- Déployer pour PEC Curative par MANIEMA



NORD KIVU

***S29/2026 293 vs 235
cas(Hausse+18)***

- Kiroitse 88
- Masisi 58
- Goma 51
- Nyiragongo 48

Facteurs Explicatifs

- Coupure d'eau dans certains quartiers à Goma
- Consommation d'eau du lac

Action en cours

- Intrants bloqués à BENI
- Déployer pour expédition des intrants par FICR
- Déployer pour les ACTQ



Choléra: Analyse hebdomadaire SE29-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Situation épidémiologique du choléra, 2026, DPS Kwango

S29/2026 113 cas et 8 décès vs 56 (Hausse +50)

- Kasongo Lunda 73/8 décès
- Popokabaka 31 cas

Facteurs Explicatifs

- 7/9 échantillons au TDR
- Analyse en cours de Radi One

Action en cours

- Prise en charge de cas
- Activité communautaire
- Surveillance épidémiologique
- CREC

Gaps

- Absence d'activités communautaires dans les ZS Hotspots
- Insuffisance des sites de chloration dans les ZS prioritaires



A Mettre en place/Riposte Intense

- Prise en charge curative(mise en place de CTC/UTC/PTRO)
- Surveillance épidémiologique
- Quadrillage
- VCO réactive